

Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC)

1. Introducción y relevancia clínica

El **Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC)** es una enfermedad mental caracterizada por la presencia de:

- **Obsesiones:** pensamientos, impulsos o imágenes intrusivas y repetitivas, reconocidas como propias pero vividas con malestar.
- **Compulsiones:** conductas o actos mentales repetitivos que el paciente realiza para reducir la ansiedad que provocan las obsesiones.

El TOC se ubica actualmente en una categoría propia dentro del DSM-5, separada de los trastornos de ansiedad, aunque mantiene una estrecha relación clínica con ellos.

Afecta aproximadamente al **2–3% de la población mundial**, con inicio típico entre los **15 y 25 años**, y curso **crónico y fluctuante**.

En Chile, es una de las causas frecuentes de consulta psiquiátrica en jóvenes y adultos, y un motivo común de **error diagnóstico en atención primaria**, donde puede confundirse con ansiedad generalizada o esquizofrenia.

□ En el **EUNACOM**, las preguntas sobre TOC se centran en:

- Diferenciar obsesión de idea delirante.
- Manejo farmacológico (ISRS a dosis altas).
- Rol de la exposición y prevención de respuesta (EPR) en psicoterapia.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El TOC es un trastorno **neurobiológico, genético y conductual**, donde se alteran los circuitos que regulan el control de impulsos y la inhibición de pensamientos.

2.1. Circuitos cerebrales involucrados

- **Corteza orbitofrontal** → genera la percepción de amenaza o “error”.

- **Cuerpo estriado (núcleo caudado)** → filtra los pensamientos automáticos.
- **Tálamo y cíngulo anterior** → amplifican la respuesta emocional.
- **Disfunción del circuito cortico-estriado-tálamo-cortical (CETC)**: hiperactividad sostenida genera pensamientos intrusivos.

Neuroimagen funcional: muestra aumento del metabolismo en la corteza orbitofrontal y el caudado, que se normaliza con ISRS o terapia cognitivo-conductual.

2.2. Neuroquímica

- **Déficit de serotonina (5-HT)**: eje central del tratamiento con ISRS.
 - **Alteraciones dopaminérgicas**: explican la eficacia de antipsicóticos en TOC resistente.
 - Disfunción del **glutamato** y del sistema GABAérgico, implicados en algunos subtipos.
-

2.3. Factores genéticos y ambientales

- Riesgo **4–6 veces mayor** en familiares de primer grado.
 - Antecedentes de **trastornos de tics o síndrome de Tourette**.
 - Factores desencadenantes: estrés, infecciones (PANDAS en niños).
-

2.4. Teoría conductual

El TOC se mantiene por **refuerzo negativo**:

- La obsesión causa ansiedad → la compulsión la reduce → se refuerza el ciclo.

Por ejemplo:

“Pensar que las manos están sucias” (obsesión) → “lavarse reiteradamente” (compulsión)
→ alivio → repetición.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Obsesiones

Pensamientos, impulsos o imágenes **recurrentes e intrusivos**, no deseados, que causan ansiedad o malestar significativo.

Ejemplos típicos:

- Contaminación (“puedo contagiarme si toco esto”).
- Duda (“dejé la puerta abierta”).
- Simetría (“los objetos deben estar perfectamente alineados”).
- Ideas agresivas o sexuales (“podría dañar a alguien”).

El paciente **reconoce que son irracionales** (insight conservado) y **trata de resistirlos**, pero sin éxito.

3.2. Compulsiones

Conductas repetitivas (lavarse, ordenar, revisar) o actos mentales (rezar, contar, repetir frases) que se realizan **para neutralizar o prevenir la ansiedad**.

Ejemplos:

- Lavado de manos excesivo.
- Comprobación constante de cerraduras.
- Ordenar simétricamente objetos.
- Repetir oraciones para evitar “malas consecuencias”.

3.3. Criterios diagnósticos (DSM-5)

1. Presencia de **obsesiones, compulsiones o ambas**.

2. Las obsesiones/compulsiones **consumen tiempo (≥ 1 h/día)** o causan malestar clínico significativo.
3. No son atribuibles a efectos de sustancias o a otro trastorno mental.

Especificadores:

- Con buen insight (reconoce que son irracionales).
 - Insight pobre o ausente (cree que son reales).
 - Con tics asociados.
-

3.4. Curso clínico

- Inicio insidioso, en adolescencia o adultez temprana.
 - Curso **crónico**, con exacerbaciones bajo estrés.
 - En niños, puede confundirse con **conductas ritualizadas normales**.
-

3.5. Diagnóstico diferencial

Entidad	Características diferenciales
Trastorno de ansiedad generalizada	Preocupaciones realistas sobre problemas cotidianos, no pensamientos irracionales.
Esquizofrenia / psicosis	Las ideas son delirantes (creencias fijas), no reconocidas como absurdas.
Trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva (TPOC)	Perfeccionismo y rigidez, sin ansiedad ni compulsiones irracionales.

Trastornos de tics / Tourette

Movimientos motores o vocales, sin contenido cognitivo obsesivo.

- ☐ En el EUNACOM: el **insight** (reconocimiento de irracionalidad) es la clave para diferenciar TOC de psicosis.
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico es **clínico**.

No existen pruebas de laboratorio específicas.

Se utilizan escalas para evaluar severidad:

- **Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale (Y-BOCS)**: evalúa intensidad y tipo de síntomas.
- **Escalas de Hamilton o Beck**: para comorbilidad depresiva.

Exámenes complementarios sugeridos:

- TSH, glicemia, hemograma → antes de iniciar ISRS.
 - En niños: descartar infecciones estreptocócicas (PANDAS).
-

5. Tratamiento (según Guía MINSAL y consenso internacional)

El tratamiento del TOC requiere una **combinación de farmacoterapia y terapia conductual**, sostenida y supervisada.

5.1. Terapia cognitivo-conductual (TCC)

Técnica principal:

- ☐ **Exposición con prevención de respuesta (EPR)**

Consiste en:

1. Exponer al paciente al estímulo que genera obsesión (p. ej., tocar una superficie “sucia”).
2. Impedirle realizar la compulsión (lavarse).
3. Mantener la exposición hasta que la ansiedad disminuya por habituación.

Objetivos:

- Romper el ciclo obsesión–compulsión.
- Reducir la ansiedad asociada.
- Disminuir la frecuencia e intensidad de las obsesiones.

Eficacia: mejora significativa en el **70–80%** de los pacientes.

Debe ser guiada por terapeuta especializado.

5.2. Farmacoterapia

Primera línea: ISRS (a dosis altas)

Los **ISRS** son el tratamiento farmacológico de elección.

Fármaco	Dosis terapéutica en TOC
Fluoxetina	40–80 mg/día
Sertralina	150–200 mg/día
Paroxetina	40–60 mg/día
Escitalopram	20–40 mg/día

Fluvoxamina 150–300 mg/día

□ Las dosis requeridas son **más altas que en depresión o TAG**, y la respuesta puede tardar **8–12 semanas**.

Segunda línea: Clomipramina (tricíclico serotoninérgico)

- Eficaz, pero con más efectos adversos (sedación, hipotensión, cardiotoxicidad).
- Dosis: **75–250 mg/día**.
- Requiere ECG previo y control en adultos mayores.

Terapia combinada

- TOC refractario: agregar **antipsicótico atípico** (risperidona 0.5–2 mg/día o aripiprazol).
 - Otras opciones: venlafaxina, augmentación con lamotrigina o NAC (N-acetilcisteína).
-

5.3. Duración del tratamiento

- Mantener fármacos por **12–24 meses** tras remisión.
 - Reducción gradual en pacientes estables.
 - Psicoterapia continua como prevención de recaídas.
-

5.4. Otras estrategias

- Educación familiar: comprensión del trastorno, evitar reforzar compulsiones.
 - Grupos de apoyo y psicoeducación.
 - En casos graves resistentes: estimulación cerebral profunda (solo en centros especializados).
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicaciones

- **Depresión mayor (hasta 60%).**
- **Aislamiento social, deterioro laboral o escolar.**
- **Conductas suicidas (riesgo 10%).**
- **Trastornos de personalidad y abuso de ansiolíticos.**

Pronóstico

- **Curso crónico y fluctuante**, pero controlable.
 - **Buena respuesta** con TCC + ISRS en 60–70% de los pacientes.
 - **Peor pronóstico:** inicio temprano, insight pobre, tics asociados, depresión comórbida.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas clínicas

1. TOC = **obsesiones + compulsiones** reconocidas como irracionales.
 2. **Insight conservado** → diferencia con psicosis.
 3. **ISRS a dosis altas** son el tratamiento farmacológico de elección.
 4. La **TCC con exposición y prevención de respuesta** es igual de efectiva.
 5. Evitar benzodiacepinas: no tratan el núcleo del TOC.
 6. La **clomipramina** es alternativa eficaz si no hay respuesta a ISRS.
 7. Educar a la familia para **no reforzar las conductas rituales**.
-



Errores comunes

- Indicar ISRS a dosis bajas o suspender antes de 12 semanas.
 - Confundir TOC con TPOC (personalidad obsesiva).
 - Usar benzodiazepinas crónicamente.
 - Diagnosticar psicosis en pacientes con obsesiones de mal contenido (sexual, agresivo).
 - No ofrecer terapia conductual (EPR).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **TOC** se caracteriza por **obsesiones (pensamientos intrusivos)** y **compulsiones (conductas repetitivas)**.
2. El paciente **reconoce la irracionalidad** de sus ideas (insight).
3. El tratamiento de elección es **ISRS a dosis altas + TCC con exposición y prevención de respuesta**.
4. La **respuesta farmacológica es lenta (8–12 semanas)**.
5. La **clomipramina** es alternativa útil, especialmente en TOC puro.
6. Evitar benzodiazepinas: no modifican el curso del trastorno.
7. El **pronóstico mejora con adherencia y apoyo familiar**.